

PRESENTATIONS DEFLECHIES

I. Introduction

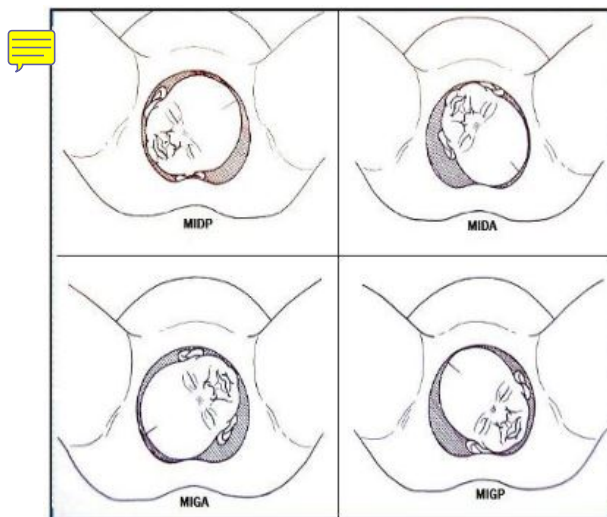
- Présentation sommet bien fléchie +++
- Défléchies <1%
 - Face** : déflexion totale 3/3
 - Front** : moyenne 2/3
 - Bregma** : légère 1/3
- Modification des diamètres fœtaux -> impact sur l'accouchement

	Bregma	Front	Face
Position fœtale			
Perception au toucher vaginal			

II. Présentation de face

1. Définition

- Déflexion totale de la tête
- Souvent secondaire au cours de travail
- Repère : menton
- Variétés :
 - Antérieur → eutociques
 - Post, transverse → doivent faire la rotation



- Diamètres :**
 - Sous mentobregmatique : 9.5 cm
 - Présternosincipital : 13-15 cm

Eutocie (si menton antérieur) : voie basse.
Dystocie (si menton postérieur) : césarienne.

2. Fréquence

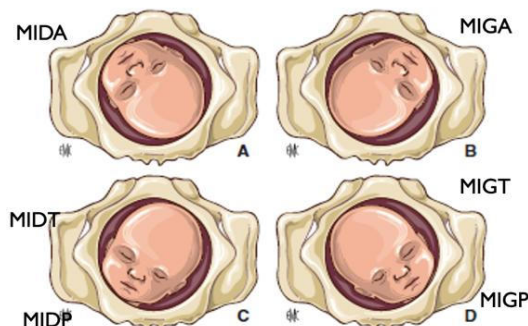
- Maroc 0.07%
- France 0.04-0.33%

3. Facteurs favorisants :

- Multiparité+++, primiparité
- Rétrécissements pelviens
- Poids fœtal : ↑ ↓
- Malformations fœtales : tumeurs cervicales
- Facteurs annexiels : hydramnios, PP, circulaire du cordon

4. Diagnostic :

a. Grossesse :



- Difficile, parfois transitoire
- Echo+++ : tête défléchie, cote du dos, étiologie ? localisation
- Radio : contenu utérin

b. Travail

- **Diagnostic tardif** : DC
- **Palper** : coup de hache
- **TV** : front-arcades orbitaires-nez-bouche-menton-grande fontanelle

c. Accouchement :

Engagement : orientation oblique ghe++= diamètre sous mentobregmatique mais

Descente et rotation : hyper déflexion → apparition d'un nouveau diamètre
présternosyncipital = de solidarisation :

- = incompatible avec l'accouchement.
- Accouchement possible si désolidarisation de tête et tronc foetal.
- Variétés antérieures +++

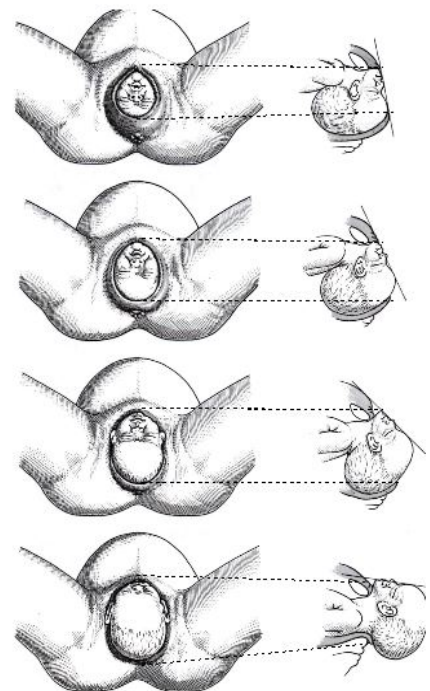
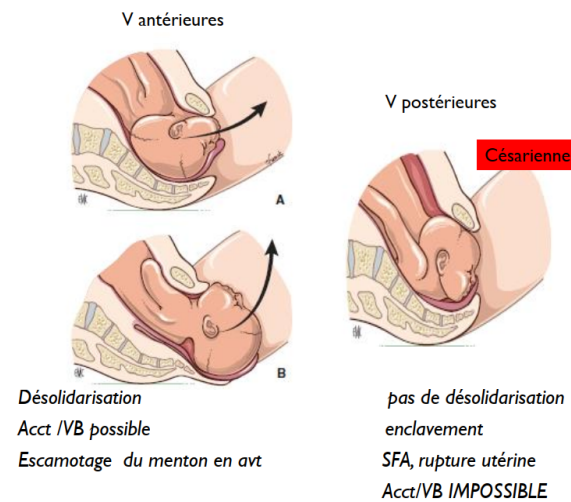
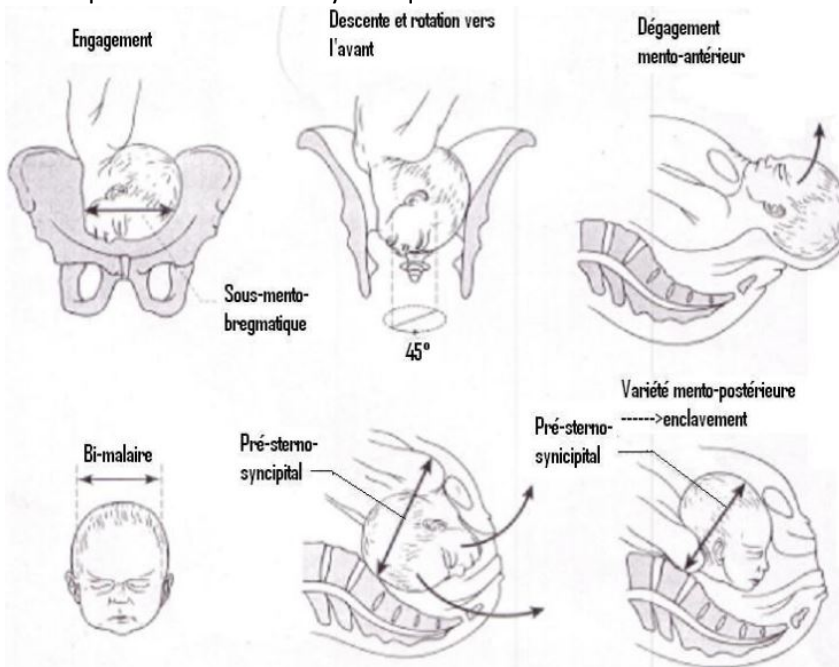
• Variétés ant :

- Désolidarisation,
- Accouchement VB possible (eutocique),
- Escamotage du menton en avant

• Variétés post, transverse :

- Pas de désolidarisation,
- Enclavement,
- SFA, rupture utérine,
- Accouchement VB impossible.

- Si pas de rotation → dystocique



d. Dégagement

- Sous menton se fixe au sous pubis
- Flexion céphalique
- Apparition : nez, yeux, arcades orbitaires, front, grande fontanelle, occiput
- Protection du périnée
- Respect de la PDE



- Surveillance du travail qui ne doit pas être longue

Diagnostic différentiel

a. Siège :

- Bouche, anus ?
- Nez ? Sacrum ?

b. Front :

- TV : fontanelle ant, jamais le menton, pb phase frontale de la face : fixation !!!



aspect en gargouille



6. Pronostic

a. **Maternel** : amélioré par l'indication rationnelle de la voie haute

b. **Néonatal** :

- Diminution de la mortalité périnatale

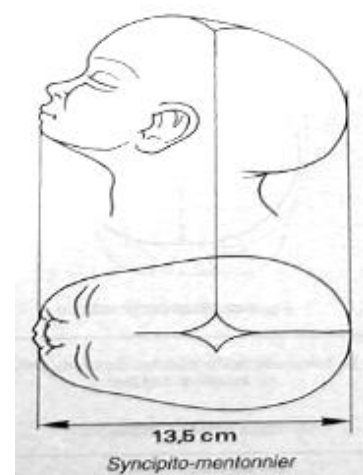
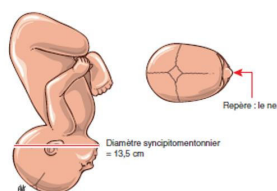


Nouveau née : opisthotonos, lordose dorsale haute, dolichocéphale, face tuméfiée, BSS, joues, lèvre cri rauque, aspect disparaît en 24-48h

III. Présentation du front

1. Définition

- Déflexion partielle du pôle céphalique (2/3)
- Présentation doit être fixée
- Phase frontale de la présentation de la face
- Repère : Nez
- Diamètre : syncipito-mentonnier = 13.5 cm
- Variétés : NIGA (Naso-Iliaque Gche Ant), NIDA, NIGP, NIDP, transverses
- HAUTEMENT DYSTOCIQUE



2. Fréquence :

- France : 1/600 - 1/1000
- Maroc 0,25%

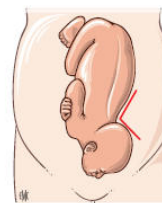
3. **Etiologies** : Idem que toutes les présentations défléchies

4. Diagnostic :

a. **Grossesse** : rarement

b. **Travail** :

- Palper abdominal : présentation verticale, fixée, élevée coup de hache moins marqué
- TV ; nez, globes oculaires, arcades sourcilières, front, grande fontanelle, bouche, menton



c. **Accouchement** :

- En dehors de la prématurité et du petit poids : diamètre syncipito mentonnier = 13.5 cm incompatible avec l'engagement et avec l'accouchement par voie basse → Césarienne

5. Pronostic :

- **Maternel** : bon si césarienne indiquée à temps
- **Front négligée** : hypertonie utérine, rupture utérine, hémorragie de la délivrance, escarres du SI, vessie, FVV
- **Nouveau née** : enclavement dans le DS, SFA → MFIU

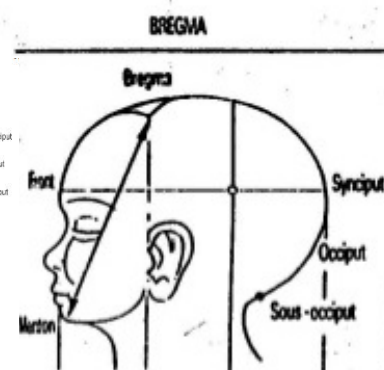
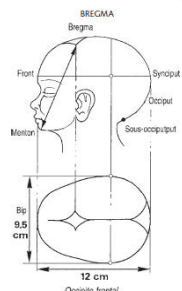
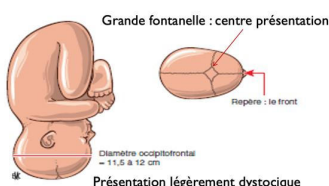
IV. Présentation du bregma

1. Définition

- Repère : front
- Présentation légèrement dystocique
- Diamètre occipito frontal : 11.5 à 12 cm

2. Fréquence :

- Souvent méconnue,

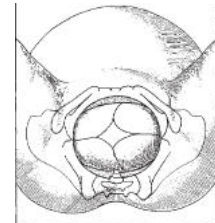
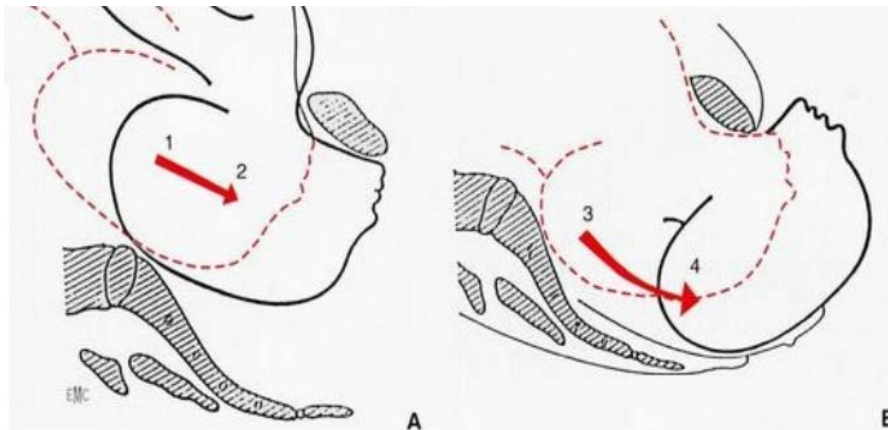
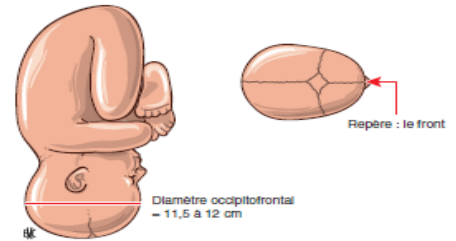


- Maroc 0.09%
- France : 1%
- 3. Etiologies :** Idem que toutes les présentations défléchies

4. Diagnostic :

Salle d'accouchement : TV → grande fontanelle au centre de la présentation, arcades sourcilières, encoche nasale, petite fontanelle, nez

- **Doute :** radio contenu utérin, écho



5. Accouchement :

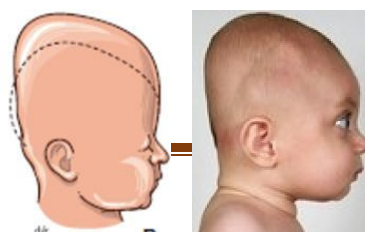
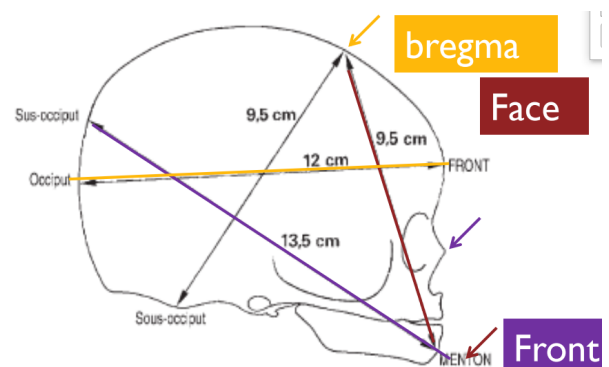
- **Orientation :** diamètre oblique
- **Variétés :** FIDA (Front iliaque Drt Ant), FIDP, FIGP, transverses
- **Engagement et descente :** RAS
- **Rotation :** souvent front en avant +++, rarement front en post
- **Dégagement :** sous occiput appuie sur la commissure post, déflexion de la tête, face se dégage sous la SP

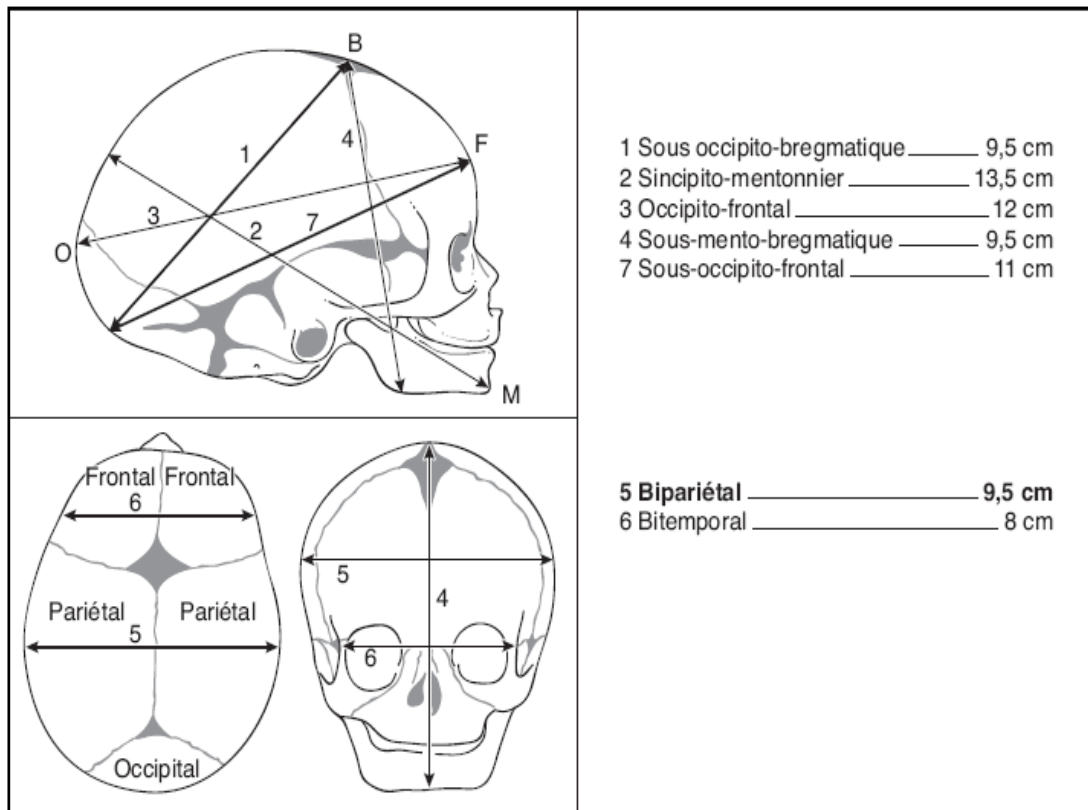


- Respecter la PDE
- Dilatation trainante
- Risque élevé de déchirures périnatales et sphinctériennes
- Extraction instrumentale par forceps, ventouse : main expérimentée
- Certains : césarienne si variétés autre que antérieures

6. Pronostic :

- **Maternel :** bon si respect des délais normaux du travail, risque infectieux si accouchement prolongé
- **Nouveau née :** déformation plastique : aspect en tour, BSS au niveau de la région bregmatique





Pronostic des types de présentation céphalique

Présentation	Eutocie	Dystocie	Accouchement		Repère	Diamètres sagittaux
			Voie basse	Césarienne		
Sommet	++		⊕		Lambda (petite fontanelle)	Sous-occipito-bregmatique 9,5 cm
Bregma		⊕	⊕ ou	⊕	Front anelle	Occipito-frontal 12 cm
Front		++		⊕	Racine du nez	Sincipito-mentonnier 13,5 cm
Face	⊕		Variété antérieure	Variété postérieure	Menton	Sous-mento-bregmatique 9,5 cm

QE!!



PRÉSENTATION TRANSVERSE

I. Introduction

- Grand axe de la mère fait angle droit avec celui du fœtus
- Repère : acromion
- Présentation dystocique
- Fréquence : Maroc 0.47%, France 0,20%
- Accouchement spontané d'un enfant eutrophe, vivant, bonne santé par voie basse : IMPOSSIBLE

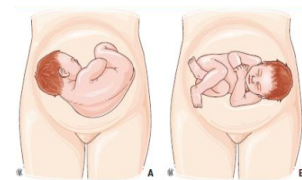
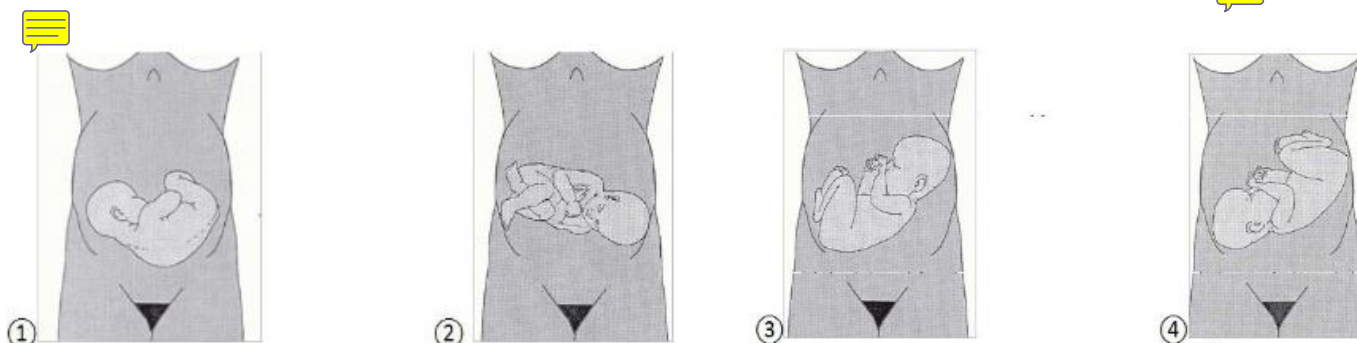


Figure 1. Position transverse.
A. Dorsocentrique.
B. Dorsoantérieure.



Figure 2. Position oblique.
A. Siège dans la fosse iliaque.
B. Tête dans la fosse iliaque.



II. Etiologies : idem que siège

Inadaptation du fœtus à l'utérus :

1. Primitive :

- **Anatomique** : utérine (malformation, pathologique (fibrome)), osseuse (BR), pelvienne (tumeur preavia)
- **Pariétale**
- **Fœtale** : PP, cordon court

2. Accidentelle :

- Multiparité,
- hydramnios,
- fœtus de petite taille : prématurité, GG, RCIU

III. DIAGNOSTIC : Fin de grossesse, début du travail

1. Grossesse

- **Inspection** : utérus étalé transversalement
- **Palper abdominal** : HU < AG présumé, pôles fœtaux au niveau des flancs, manœuvre de Léopold
- **Auscultation** : BCF dans la région ombilicale du côté de la tête fœtale.
- **TV** : excavation vide, présentation haute
- **Echo** : confirme le dg, étiologie ?
- **Radio contenu utérin**

2. Travail :

- **PDE intacte** : TV idem qu'en dehors du travail
- **PDE rompue** :
 - Variétés : AIDA, AIDP, AIGA, AIGP, transverses
 - TV, acromion, origine cou, creux axillaire, gril costal, MS

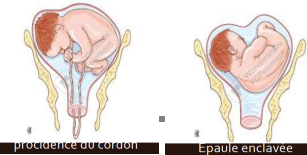


Epaule négligée



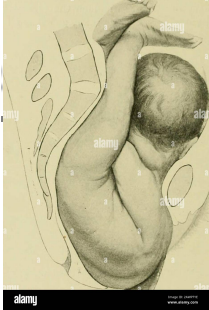
IV. Evolution : Evolution spontanée : dystocique

- ❖ Epaule méconnue
- ❖ Epaule négligée : patiente en travail, membranes rompues, présentation engagée immobilisée, infection
oulaire existe (déclarée, latente), fœtus a négativé = rançon de la négligence
- ❖ Version spontanée : exceptionnelle



Épaule enclavée

- L'accouchement du fœtus conduplicato corpore (plié en deux), se rencontre parfois lorsque le fœtus est de petite taille et macéré.
- La présentation étant irrégulière les contractions utérines sont de mauvaises qualités et la dilatation cervicale lente, la rupture de la poche des eaux est précoce. Quand les contractions utérines deviennent plus intenses, l'épaule s'engage dans le bassin, la tête et le corps restent au-dessus du détroit supérieur, le cou s'allonge et l'on observe un arrêt de progression (figure 6). L'utérus se moule sur le fœtus, c'est l'enclavement de la présentation qui peut avoir deux conséquences :
 - soit la rupture utérine
 - soit l'inertie utérine corollaire l'infection



- ❖ **Accouchement en conduplicato corpore** : plié en deux comme un livre : mort fœtale et petit poids.
- ❖ **Procidence du cordon**
- ❖ **Rupture utérine** : spontanée/enclavement de la présentation dans le détroit supérieur ou provoquée
- ❖ **Inertie utérine**
- ❖ **Infection**

V. CAT

1. Grossesse : Version par manœuvre externe

- **But** : transformer une présentation transverse en présentation céphalique
- **Quand** : vers 36-38 SA
- **Ou** : bloc obstétrical
- **CI absolues** : BR, utérus multicatriciel, PP, souffrance fœtale, GG, oligo-amnios, iso-immunisation, sérologie VIH+, refus de la parturiente
- **CI relatives** : malformation fœtale (laparoschisis, spina bifida), RPM, MAP, utérus malformé, utérus unicatriciel, placenta antérieur, primipare âgée
- **Technique** :
 - Proximité d'un bloc opératoire
 - Vessie vide
 - ERCF 30min, tocolyse
 - Echo obstétricale
- **Après la VME** :
 - ERCF 60 min
 - Si Rh négatif : Anti D
- **Complications** :
 - SFA, HRP, RPM, Rupture utérine, décollement placentaire
- **Echec** :
 - Césarienne
 - Si tout est normal : retentative

2. Au cours du travail :

- **Primipare** : césarienne
- **Multipare** : VME, VMI (membranes intactes, dilatation complète), césarienne.

👉 VMI ? :

- **But** : transformer une présentation transverse en présentation de siège-> grande extraction de siège :
 - Préhension
 - Mutation
 - Grande extraction

➔ OUI



→ NON



3. Présentation transverse sur J2

- Seule indication raisonnable actuellement admise pour VMI
- Membrane intacte
- Dilatation complète
- Utérus non rétracté
- Pas de DFP_A
- Petit poids

VI. Conclusion

- ✓ Présentations défléchies : reflet d'une pathologie materno fœtale
- ✓ Démarche étiologique
- ✓ Examen clinique, Echo obstétricale
- ✓ Diagnostic précoce= prise en charge adéquate
- ✓ Pronostic materno fœtal dépend de la précocité du diagnostic